
MONOGRAFÍA DEL PRODUCTO

NEUFIL, Jarabe

Broncodilatador

1. Denominación del medicamento

Neufil, jarabe.

2. Composición cualitativa y cuantitativa

Diprofilina, 100 mg/15 ml

3. Forma farmacéutica

Jarabe.

4. Datos clínicos

4.1. Indicaciones terapéuticas

Profilaxis y tratamiento de enfermedades pulmonares obstructivas: asma, bronquitis crónica, enfisema pulmonar.

4.2. Posología y forma de administración

A establecer por el Médico según el caso. Todavía la posología recomendada es la siguiente:

Niños: 14 mg/kg/día, en 3 ó 4 dosis parcelarias (1 cuchara de las de té (5 ml) ó de las de postre (10 ml)) de NEUFIL Jarabe cada 6 ó 8 horas, según la edad. La dosis máxima no está aún establecida, pero no es necesario sobrepasar la dosis máxima diaria de 60 mg/kg/día, para el adulto, repartida por 4 tomas diarias. La duración del tratamiento en las crisis agudas será de algunos días, tiempo suficiente para debelar los síntomas agudos; el tratamiento de manutención es más largo, ya que deberá mantenerse hasta la supresión estable de la sintomatología o hasta que el Médico decida cambiar la terapéutica.

4.3. Contraindicaciones

Epilepsia u otros síndromes convulsivantes. Hipersensibilidad conocida al medicamento.

4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo

Los niños son más sensibles que los adultos a los efectos indeseables de las metilxantinas, así que los intervalos entre las dosis parcelarias deben ser completamente cumplidos. Considerando que la diprofilina no es metabolizada por vía hepática, no es necesario tener las precauciones habitualmente recomendadas para la teofilina.

4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

La determinación de las concentraciones plasmáticas de diprofilina no es falsamente aumentada por la ingestión de bebidas cafeicas (café, té, chocolate) o por otros fármacos. El probenecid retrasa la eliminación de la diprofilina, lo que obliga a la reducción de las dosis. Los estimulantes adrenérgicos beta y otras metilxantinas ejercen un efecto broncodilatador y estimulante central aditivo cuando utilizados en simultáneo con la diprofilina. El probenecid y otros medicamentos que bloquean los procesos de secreción y reabsorción tubular reducen la velocidad de secreción activa y de excreción de la diprofilina, aumentando los valores de las concentraciones plasmáticas y la semivida de esas concentraciones. La fuerte interferencia de muchas situaciones o fármacos sobre la actividad de la teofilina no se observa con la diprofilina, con las consecuentes e importantes ventajas terapéuticas a favor de la diprofilina.

4.6. Embarazo y lactancia

Aunque no estén descritos casos de toxicidad en la mujer embarazada, se recomienda por prudencia utilizar la diprofilina solamente cuando estrictamente indispensable. Lo mismo se aplica a las madres lactantes puesto que el medicamento pasa para la leche materna.

4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

No tiene.

4.8. Reacciones adversas

Son poco frecuentes y de intensidad ligera. Todavía no puede excluirse la posibilidad de apareamiento de alguna sintomatología dispéptica, relacionada con el medicamento. También puede ocurrir, sobre todo con dosis elevadas en niños, fenómenos moderados de estimulación central. Los fenómenos de hipersensibilidad son, sobre todo, cutáneos y de muy rara incidencia. Estos efectos suelen desaparecer al interrumpirse la medicación, pero en casi la totalidad de los casos no es necesario interrumpir la terapéutica.

4.9. Sobredosis

En casos de sobredosificación o intoxicación los primeros síntomas son vómitos, nerviosismo y agitación. En casos más graves, en enfermos particularmente sensibles, puede observarse confusión mental y convulsiones. El tratamiento es sintomático y no hay antídotos específicos.

5. Propiedades farmacológicas

5.1. Propiedades farmacodinámicas

Droga que actúa sobre el aparato respiratorio: antiasmático.

La diprofilina único componente activo de NEUFIL, es un derivado de la teofilina, la dihidroxipropilteofilina. Sin embargo, la diprofilina es una sal de teofilina, no es metabolizada a teofilina, la diprofilina actúa por su propia molécula; el mecanismo de acción de la diprofilina al igual que teofilina ocurre por inhibición de la fosfodiesterasa, por lo que se aumenta la concentración intracelular de AMP cíclico, particularmente en las células musculares lisas y especialmente en las de los bronquios; esta acción se traduce en un efecto inhibidor del broncoespasmo, con aumento del flujo de aire y de la capacidad vital. Aunque en grado menor, la diprofilina ejerce también otras acciones características de las metilxantinas (dilatación coronaria, diuresis, moderada estimulación cardíaca, cerebral y del músculo esquelético). Sin embargo tras la administración de dosis terapéuticas, estas acciones no se traducen en reacciones adversas, con significancia clínica. Aún hay que señalar que la diprofilina a diferencia de la teofilina, puede provocar disminución del umbral para convulsiones, lo que contraindica en los pacientes epilépticos. La eficacia y la buena tolerabilidad de la diprofilina están bien comprobadas por ensayos clínicos controlados. El promedio de las respuestas terapéuticas favorables se sitúa en aproximadamente el 90%. La tolerabilidad excelente de la diprofilina ha sido siempre comprobada, confirmando el perfil farmacodinámico diseñado por los ensayos en los animales de experiencia, en los cuáles la toxicidad aguda de la diprofilina es 5 veces más baja que la de la teofilina.

5.2. Propiedades farmacocinéticas

La presencia de un grupo hidrofílico dihidroxipropil confiere a la diprofilina una solubilidad en agua 40 veces más alta que la de la teofilina; las soluciones de diprofilina son neutras y su molécula es estable frente al ácido clorhídrico del estómago. El conjunto de estas características hace de la diprofilina una metilxantina broncodilatadora de gran interés terapéutico, por las consecuencias farmacocinéticas y de tolerabilidad que tales características implican (además de la prácticamente ausencia de estimulación central y del corazón). La diprofilina se absorbe muy bien por el tracto digestivo. La biodisponibilidad media es del 75% con pequeñas variaciones interindividuales. La vida media plasmática es de 2,1 horas tras la administración intravenosa. La distribución es muy amplia y rápida y el volumen medio de distribución es de 0,6 L/kg. La metabolización de la diprofilina no está completamente conocida, pero se sabe que es poco intensa y que no hay transformación en teofilina. Después de una inyección intravenosa, se recuperan en la orina el 96% de la dosis administrada. La excreción es esencialmente urinaria; tras la administración oral se recupera en la orina el 72% de la dosis administrada.

6. Datos farmacéuticos

6.1 Lista de excipientes

Sacarosa, Etanol, agua purificada, Nipasept, Aroma especial.

6.2 Incompatibilidades

Por falta de estudios de incompatibilidad, este medicamento no debe ser mezclado con otros.

6.3 Periodo de validez

5 años.

6.4 Precauciones especiales de conservación

Mantenga por debajo de 30°C. Mantenga el frasco bien cerrado.

6.5 Naturaleza y contenido del envase

Envase de cartulina conteniendo un frasco de vidrio de color ámbar, tipo III.

6.6 Instrucciones de uso/manipulación (y eliminación)

No existen requisitos especiales. La eliminación de los productos no utilizados o de los envases se establecerá de acuerdo con las exigencias locales.

7. Titular de la Autorización de Introducción en el Mercado

BIAL – Portela & C^a, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado -Portugal

8. Número de Autorización de Comercialización

PF-10277

9. Fecha de la primera Autorización/Renovación de la Autorización

10. Fecha de la revisión del Texto